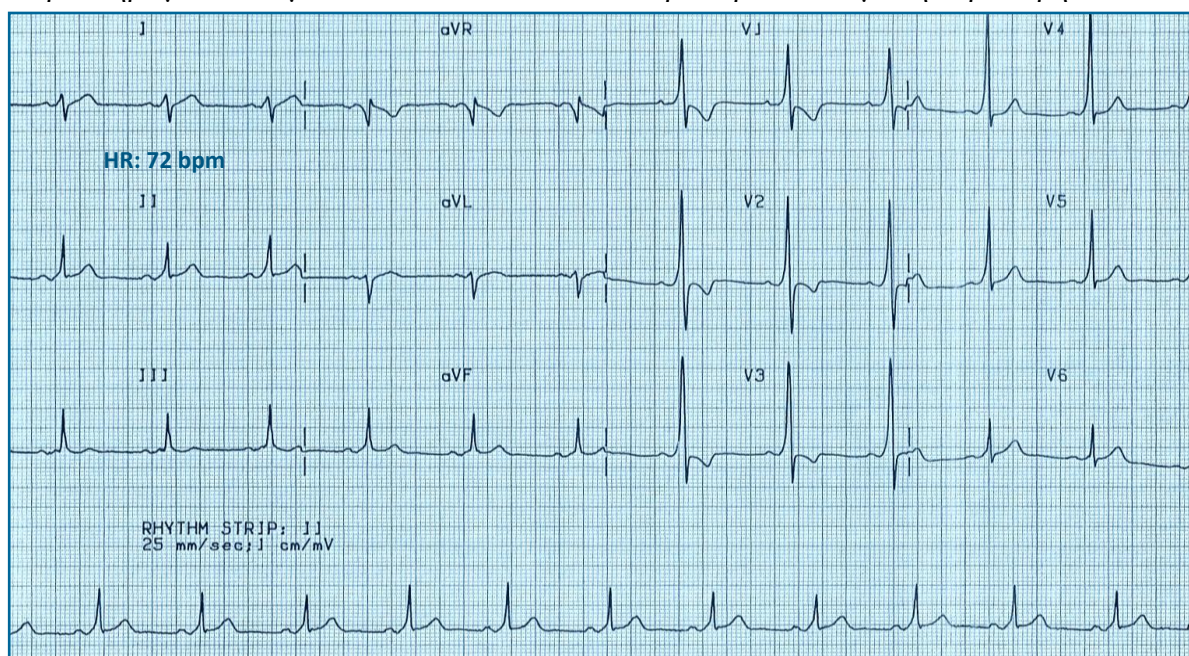


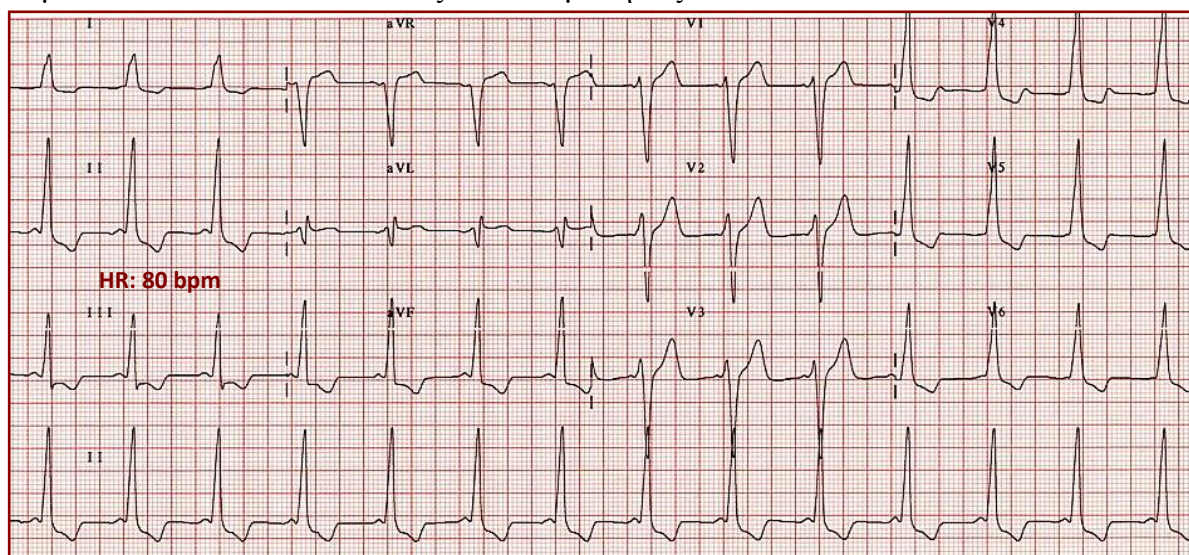
Σύνδρομα Προδιέγερσης (Wolff - Parkinson - White)

- Τα σύνδρομα προδιέγερσης (επιπολασμός: 0,1-0,3%) αφορούν στις περιοχές εκείνες του κοιλιακού μυοκαρδίου που ενεργοποιούνται από ένα κολπικό ερέθισμα συντομότερα από ό,τι θα ήταν αναμενόμενο αν η διαδρομή του ερεθίσματος επιτελούνταν ομαλά μέσω της κανονικής οδού και της φυσιολογικής καθυστέρησης του ερεθίσματος στον κ-κ κόμβο.
- ΗΚΓφικά εμφανίζεται μορφολογία καρδιακών συστολών εξ συνθλίψεως, δηλαδή:
 1. Βραχύ διάστημα PR ($PR < 120 \text{ msec}$) ή βραχύ διάστημα PQ.
 2. Κύμα «δ» (κύμα προδιέγερσης) κατά την έναρξη του QRS.
 3. Διεύρυνση του συμπλέγματος QRS ($QRS > 120 \text{ msec}$, εις βάρος του διαστήματος PQ).
 4. Διαταραχές της επαναπόλωσης (στις απαγωγές εκείνες όπου επικρατεί το έπαρμα R εμφανίζεται πτώση του διαστήματος ST κι αναστροφή του επάρματος T· βλέπε 2^ο ΗΚΓ).
- Περιγράφονται δύο τύποι του συνδρόμου WPW, ο τύπος A και ο τύπος B.

Ο τύπος A, χαρακτηρίζεται από υψηλό έπαρμα R στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές. Μπορεί ενίοτε να συγχέεται με αποκλεισμό του δεξιού σκέλους (RBBB), εμφανίζεται δε όταν το παραπληρωματικό δεμάτιο του Kent συνδέει τον αριστερό κόλπο με την αριστερή κοιλία.



Ο τύπος B, χαρακτηρίζεται από κοιλιακό σύμπλεγμα QS στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές και μοιάζει με εικόνα αποκλεισμού του αριστερού σκέλους (LBBB). Εμφανίζεται όταν το δεμάτιο του Kent συνδέει τον δεξιό κόλπο με τη δεξιά κοιλία.



- Σε ασθενείς με σύνδρομο WPW εμφανίζεται υψηλό ποσοστό ταχυαρρυθμιών, όπως:
 - I. Κολπικός Πτερυγισμός (5%).
 - II. Κολπική Μαρμαρυγή (10-20%).
 - III. Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία επανεισόδου (40-80%).
- Μεταξύ των ασθενών με σύνδρομο WPW, καθώς και των ασθενών με Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία (PSVT) το 80-90% αυτών άγει τα ερεθίσματα ορθόδρομα με στενά QRS, ενώ το 10-20% άγει τα ερεθίσματα αλλόδρομα με ευρέα συμπλέγματα QRS.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε σταθεροποιημένους ασθενείς (χωρίς σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας και με στενά συμπλέγματα QRS), αφού τους καθησυχάσουμε επιχειρούμε βαγοτονικούς χειρισμούς.
 - ✓ **Μάλαξη καρωτιδικού κόλπου:** Αφού ακροαστούμε προσεκτικά τις καρωτίδες και επιβεβαιώσουμε την απουσία φυσιήματος, μαλάσουμε ήπια, για 8-10 δευτερόλεπτα, τον καρωτιδικό κόλπο από την πλευρά του μη επικρατούς εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Ποτέ δεν γίνεται ταυτόχρονη μάλαξη των καρωτιδικών κόλπων και στις δύο πλευρές.
 - ✓ **Χειρισμός Valsalva:** Με τον ασθενή σε κεκλιμένη θέση, του ζητείται να σφίχθει για 10 δευτερόλεπτα ή να φυσήξει σε μία σύριγγα 20 ml προσπαθώντας να ανυψώσει το έμβολο κατά 10-20 ml. Υπτιασμός του ασθενούς με ταυτόχρονη ανύψωση των κάτω άκρων βοηθά στη φλεβική επιστροφή και οδηγεί στην έκλυση του αντανακλαστικού.
2. Σε ασθενείς με σύνδρομο WPW και υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα QRS (ορθόδρομη) η αντιμετώπιση παραμένει η ίδια όπως στις υπόλοιπες υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες επανεισόδου. Τοποθετούμε λοιπόν ευρεία φλεβική γραμμή και χορηγούμε **Αδενοσίνη** (1 amp. Adenocor 6 mg, iv-bolus), ακολουθούμενη από bolus έγχυση 20 ml φυσιολογικού ορού NaCl 0,9% για να ωθήσουμε το φάρμακο άμεσα στην κυκλοφορία. Εφόσον η ταχυκαρδία δεν αναταχθεί, επαναλαμβάνουμε μετά από 2 λεπτά τη χορήγηση Αδενοσίνης σε διπλάσια δόση, δηλαδή 12 mg (2 amp. Adenocor των 6 mg, iv-bolus). Η χορήγηση Αδενοσίνης μπορεί να επαναληφθεί άλλη μια φορά ακόμα (3^η δόση), μετά από 2-3 λεπτά, σε δοσολογία 18 mg (3 amp. Adenocor) εφόσον κριθεί απαραίτητο.
3. Σε ασθενείς με ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα QRS και με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, μπορούμε εναλλακτικά να χορηγήσουμε **Βεραπαμίλη** 5-10 mg (δηλαδή αναρροφούμε 2 amp. Isortin των 5 mg μαζί με 10-15 ml N/S και χορηγούμε βραδέως ενδοφλεβίως εντός 30-60 sec). *Για να αποφύγουμε ή να αναστρέψουμε την υπόταση και τη βραδυκαρδία που προκαλεί η Βεραπαμίλη, χορηγούμε 3-5 ml Χλωριούχο Ασβέστιο 10% ή 10 ml Γλυκονικό Ασβέστιο 10%, διαλυμένα σε 100 ml N/S, σε διάστημα 5-10 λεπτών.* Η δόση Βεραπαμίλης μπορεί να επαναληφθεί μετά από 15 λεπτά, μέχρι ορίου 30 mg.
4. Σε ασθενείς με WPW και υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT) με ευρέα QRS (αλλοδρομία) ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας και η πιθανότητα εξαλλαγής σε κοιλιακή μαρμαρυγή. Οι ασταθείς ασθενείς απινιδώνονται άμεσα με ενέργεια 50-100 J. Στους ασθενείς αυτούς αντενδείκνυται η χορήγηση Αδενοσίνης, αναστολέων διαύλων ασβεστίου (**Βεραπαμίλη, Διλτιαζέμη**) ή β-αποκλειστών προς ανάταξη της ταχυαρρυθμίας.
5. Στους ανωτέρω ασθενείς, εφόσον είναι σταθεροί, μπορεί να χορηγηθούν ενδοφλεβίως 100 mg **Προκαϊναμίδη**, κάθε 5 λεπτά. Έτσι, από 1 amp. των 10 ml Pronestyl 100 mg/ml, αναρροφούμε 1 ml φαρμάκου μαζί με 10 ml N/S και χορηγούμε αργά εντός 1-2 λεπτών. Επαναλαμβάνουμε την ίδια δόση της Προκαϊναμίδης, ανά 5-10 λεπτά, μέχρι ανατάξεως της αρρυθμίας ή μέχρι να χορηγηθεί συνολικά 1 gr Pronestyl, ήτοι συνολικά 1 amp.

☛ Σε περιπτώσεις συχνών υποτροπών - παρά τη λήψη επαρκούς φαρμακευτικής αγωγής - των σοβαρών κρίσεων είτε υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, είτε κολπικής μαρμαρυγής, συνιστάται τελικά ο κατηριασμός - **ablation** (με ειδικό ηλεκτρόδιο ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας ή σπανιότερα, χειρουργική διατομή ή κρυοπηξία) του παρακαπητηρίου δεματίου του Kent, μετά από λεπτομερή ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο και ακριβή εντόπιση αυτού.

